

TEMA 1.8 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Patología Pilonidal

PERFIL EUNACOM 4.01.1.018

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología de la Región Sacrococcígea

La zona interglútea superior y sacrococcígea es asiento frecuente de diversas alteraciones del desarrollo epitelial, denominadas globalmente como patologías pilonidales. Es fundamental en el nivel primario distinguir entidades de manejo expectante crónico contra aquellas que obligan a intervenciones o descartar un compromiso neurológico neonatal.

1. Quiste Pilonidal y sus Complicaciones

Es una malformación congénita cutánea inofensiva caracterizada por la invaginación de folículos pilosos que logran acumular detritus en la línea media o levemente paramedial de la hendidura natal. -

Clínica: Sobre elevación palpable o sensación de "bulto" en la base sacrococcígea inferior, ocasionalmente acompañada por un poro/hoyuelo comunicante (*pit*) desde donde asoman pelos o gotea material esporádicamente. - **Evolución:** Es fundamentalmente **asintomático** y puede persistir décadas inalterable. -

Complicaciones (Infección): El quiste encapsulado estancado es propenso a sobreinfectarse microbiológicamente (típicamente con flora perineal o *S. aureus*). Cuando esto cursa: - **Absceso Pilonidal:** Foco rojo inflamatorio, aumento de temperatura y fluctuación inmensamente doloroso al sentarse. - **Fístula Pilonidal:** Cuando el absceso supura espontáneamente y drena un túnel hacia afuera.

• **Tratamiento del Quiste Pilonidal:**

- **Asintomático original:** Simple y llana **Observación**, tranquilizar al paciente.
- **Primera Abscedación aguda:** **Incisión y Drenaje quirúrgico urgente**, acompañándose de tratamiento antibiótico coadyuvante enfocado (Ej. Cloxacilina o para cobertura mixta).
- **Múltiples recurrencias o fístulas crónicas:** Derivar para **Cirugía de Resección/Excisión radical definitiva**, removiendo la cápsula quística por completo para terminar el ciclo inflamatorio.

(Nota diferencial: Un absceso perianal se ubica rodeando el borde del esfínter anal y presenta un riesgo altísimo de fístulas anorrectales complejas, mientras que el absceso pilonidal asienta metros más superiormente en el sacro).

Evaluación Sacrococcígea en el Recién Nacido

Dentro de la exploración neonatal de la base raquídea, los "hoyuelos" deben examinarse buscando estigmas neurológicos axiales:

Fosita Pilonidal (Fosita Sacra Simple)

- **Definición:** Depresión o hundimiento cerrado ciego simple en el surco interglúteo. - **Significado Clínico:** Hallazgo fenotípico anatómico **absolutamente normal y fisiológico**. - **Conducta:** No presenta asociación directa con defectos del cierre del tubo neural. Observación pasiva (A menos que su trayecto sea extremadamente profundo, atípico, asimétrico de los márgenes o de base no visualizable).

Seno Pilonidal Congénito y Disrafismos

- **Definición:** Corresponde propiamente a una masa, tumoración sacra o prominencia quística densa localizada en la zona basal lumbosacra. - **Significado Clínico:** Es altamente infrecuente pero es considerado un estigma severo marcador anatómico de **Disrafia Espinal** (Espina bífida oculta subyacente mal cerrada). - **Tratamiento/Conducta Específica:** Indicación formal perentoria de solicitar **Ecografía Lumbar o Lumbosacra inicial** en busca de lipomeningoceles u ojivas de la médula anclada.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Pregunta obligada de Examen Neonatal: **Marcadores Cutáneos de Disrafia Espinal Oculta (Estigmas de Alerta):** 1. Zona de gran hipertrichosis localizada lumbosacra (Pezón de Pelo / Mechón de Pelo profuso atípico). 2. Hemangiomas ubicados en la columna / planos sacros mediales. 3. El propio Seno Pilonidal tumoral evidente de la línea media y lipomas lumbosacros. 4. (Punto gris) Fositas excesivamente complejas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de veinticinco años consulta por un aumento de volumen doloroso, eritematoso y fluctuante en la región sacrococcígea. Ha tenido dos episodios similares previos que se trataron con drenaje. ¿Cuál es la conducta más adecuada ahora?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Pilonidal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El quiste pilonidal asintomático se observa; si se complica con absceso se drena; si recidiva más de una vez se extirpa quirúrgicamente.
- La fosita pilonidal es un hoyuelo sacro normal en niños, sin riesgo de espina bífida oculta, salvo que sea muy profunda o compleja.
- El seno pilonidal es un aumento de volumen sacro, no un hoyuelo, y sí tiene riesgo de disrafia espinal; requiere ecografía lumbosacra.
- Los tres signos de disrafia espinal oculta son la hipertrichosis lumbar, el seno pilonidal y el hemangioma lumbosacro.
- El absceso pilonidal se drena y se indica antibiótico; si recurre se extirpa el quiste completo para tratamiento definitivo.
- La fístula pilonidal es la apertura espontánea del absceso hacia la piel y se trata con extirpación quirúrgica.
- La diferencia clave entre fosita y seno pilonidal es que la fosita es un hoyuelo normal sin riesgo, y el seno es un aumento de volumen con riesgo de disrafia.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA PILONIDAL)

PREGUNTA 1

Un paciente de veinticinco años consulta por un aumento de volumen doloroso, eritematoso y fluctuante en la región sacrococcígea. Ha tenido dos episodios similares previos que se trataron con drenaje. ¿Cuál es la conducta más adecuada ahora?

- A) Solo drenaje del absceso nuevamente
- B) Antibióticos endovenosos sin cirugía
- C) Extirpación quirúrgica del quiste pilonidal
- D) Observación porque es benigno
- E) Resonancia magnética para evaluar extensión antes de decidir

PREGUNTA 2

Un recién nacido llega al control del niño sano. Al examen de la zona lumbosacra se observa un pequeño hoyuelo de dos milímetros de diámetro, sin aumento de volumen, sin pelo, sin hemangioma. ¿Cuál es la conducta?

- A) Ecografía lumbosacra urgente para descartar espina bífida
- B) Tranquilizar a los padres, es una fosita normal sin riesgo de disrafia
- C) Resonancia magnética de columna para descartar disrafia
- D) Derivación urgente a neurocirugía
- E) Extirpación quirúrgica preventiva

PREGUNTA 3

Un lactante de tres meses tiene un aumento de volumen lumbosacro de un centímetro de diámetro, blando y no doloroso. ¿Cuál es la conducta?

- A) Tranquilizar porque es una fosita normal
- B) Ecografía lumbosacra para descartar disrafia espinal
- C) Cirugía urgente de extirpación
- D) Observación hasta los seis meses y reevaluar
- E) Resonancia magnética de cerebro para descartar hidrocefalia

RESUMEN: PATOLOGÍA PILONIDAL

La patología pilonidal abarca varias condiciones ubicadas en la zona sacrococcígea. El quiste pilonidal es un aumento de volumen congénito, habitualmente asintomático, que puede presentar un hoyuelo o salida de secreción. Si no se ha complicado, se observa. Si se complica con absceso, se drena e indica antibióticos. Si recurre más de una vez, se extirpa quirúrgicamente. El absceso pilonidal se ve rojo e inflamado y hay que drenar. La fístula pilonidal es la apertura espontánea del absceso hacia la piel y también se trata con extirpación quirúrgica. En la pediatría, la fosita pilonidal es un pequeño hoyuelo en la zona sacra, es algo normal y no tiene riesgo de espina bífida oculta. En cambio, el seno pilonidal es un aumento de volumen en la misma zona, no un hoyuelo, y sí tiene riesgo de disrafia espinal, por lo que obliga a hacer una ecografía lumbosacra para descartarla. Otros signos de disrafia espinal oculta son la zona de hipertriosis lumbar y el hemangioma lumbosacro. En resumen, la clave clínica es distinguir la fosita de un hoyuelo simple y normal, del seno pilonidal que es un aumento de volumen y que requiere estudio para descartar disrafia. El quiste pilonidal del adulto se observa si está asintomático, se drena si está abscedado y se extirpa si recidiva.